

INDICADO POR: Dra Andreia Bisnha  
 X ACOMPANHAMENTO ( ) CONSULTA  
 NS

## ITANOEL DE FREITAS SILVA

IDADE: 58 PESO: 132 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Comerciante  
 SINTOMAS: Sonolência diurna, despertares noturnos, Refluxo gastroesofágico  
 QUEIXAS: TEVE - ESQUISTOSSOMOSE.  
 MEDICAMENTOS: Venzo / Oxalato Ercitalopam  
 MÉDICO: Dra Andreia Bisnha / Drº Zampira.  
 MARCAPASSO: ( ) S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ( ) S (X) N  
 EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza  
 HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20:30-21h  
 HORA QUE DORME: 22:30-23h HORA QUE ACORDA: 7h  
 COCHILLO ( ) S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S ( ) N ( ) EVENTUALMENTE  
 TEM FILHOS: ( ) S (X) N / DORMEM NO QUARTO: (X) S ( ) N PET NO QUARTO: ( ) S (X) N  
 BEBIDA ALCOÓLICA: ( ) S ( ) X NA SEMANA (X) N várias vezes  
 FUMO: ( ) S ( ) MAÇO/DIA ( ) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 20 anos  
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 3-4x  
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: global CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:  
 OVERLAP: asma MALLAMPATI: IV IAH: 88 e/h SPO2: 71%  
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ( ) S ( ) N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

19/12/24 Avaliação Locação Masc N30 (M)  
 P=4-12 cmH<sub>2</sub>O

Natasha

27/12/24 P=40,2 cmH<sub>2</sub>O PGO: 11,9 cmH<sub>2</sub>O

IAH=9,0 e/h (AO:5,4 AC:0,0)

m uso=4h18 min

fuga=35 e/min \* NÃO Atendeu consulta online \* Sônia

03/01 não atendeu, enviou msg p/ esposa.

25 Conversei por vídeo ele disse que está com tosse e dificuldade p/ dormir.

Orientei a elevação da cabeceira da cama

P=4-12 cmH<sub>2</sub>O / IAH=6,6 / Fuga=14,4 l/min

21/01 P=9,6 cmH<sub>2</sub>O

25 IAH=5,5 e/h

m. de uso: 4h41'

fuga=11,8 l/min

dia 17/01 dormiu de DD.

Relata que estava com refluxo, causando tosse ajusto o CPAP.

Ana.

18/02 Falta

91/03 P= 11.5  
25 IAH= 9.2 e/ev  
m. de uso= 3R  
fuga= 9,4 lpu.

fua Cláudio

28/04 P= 9.0 cm H<sub>2</sub>O  
25 IAH= 7.3 e/ev  
m. de uso: 3h45'  
fuga= 24.2 lpu.

Oriento sobre o uso contínuo

fua.

12/08 P= 9 cm H<sub>2</sub>O  
25 IAH= 6.4 e/ev  
M. de uso= 5h20  
fuga= 3,8 lpu

fua Cláudio

Dr. Alvaro Nakano - CRM-SP 84.287 - RQE 20296  
Dr. Andréia A. Bisanha - CRM-SP: 112.331 - RQE 101925

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO  
**NAKANO MEDICINA**  
OTORRINOLARINGOLOGIA

Encaminho ITANOEL FREITAS SILVA com  
apneia do sono grave (IAH:88/h) para  
titulação e adaptação de CPAP.

Grata.

Dra. Andréia A. Bisanha  
CRM 112331  
Otorrinolaringologia

CID 10: \_\_\_\_\_

Autorizo a Informação.

**Imunoterapia**  
(vacina para alergia)  
teste cutâneo para alergia  
PRICK TEST

**BOTOX**

Fonoaudiólogo  
Otorrinolaringólogo

Audiometria

Impedanciometria

Emissões Otoacústicas

(teste da orelhinha)

BER

Eletrococleografia

Vectoeletronistagmografia

Processamento Auditivo Central

Video Estroboscopia de Laringe

Video Endoscopia Nasossinus

Video Laringoscopia com fol

CONSULTA DIA:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_:\_\_\_\_

**CARAGUATATUBA**

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 25 - 2º andar  
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 3883.3849

contato@nakanomedicina.com.br

NAKANO MEDICINA S/E LTDA - CNPJ 04.518.000/0001-30

Nome: ITANOEL DE FREITAS SILVA

Data de Nascimento: 23-10-1965

IMC: 36,57

Sexo: Masculino

Data do exame: 31-10-2024

Peso: 112 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DRA. ANDREA ALESSANDRA

BISANHA

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 31-10-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 521,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 186,0 minutos. O tempo total de sono foi de 457,5 min, eficiência de 87,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,3%; estágio N2: 78,8%; estágio N3: 4,9%; sono REM: 15,0%. O índice de despertares foi de 64,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 88,0/hora, sendo 23 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 606 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 71%, permanecendo 41,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 107 bpm e NREM de 50 - 104 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 88,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Obs: paciente com tosse intensa no dia do exame!

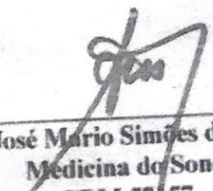
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157